



UHASSELT

KNOWLEDGE IN ACTION

Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

master in systeem- en procesinnovatie in de
gezondheidszorg

Masterthesis

***De gehanteerde strategieën van hoofdverpleegkundigen bij opgelegde veranderingen
in ziekenhuizen***

Jorien Stassen

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg

PROMOTOR :

Prof. dr. Sven DE WEERDT



UHASSELT

KNOWLEDGE IN ACTION

www.uhasselt.be

Universiteit Hasselt
Campus Hasselt:
Martelarenlaan 42 | 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek:
Agoralaan Gebouw D | 3590 Diepenbeek

2025
2026



Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

master in systeem- en procesinnovatie in de
gezondheidszorg

Masterthesis

***De gehanteerde strategieën van hoofdverpleegkundigen bij opgelegde veranderingen
in ziekenhuizen***

Jorien Stassen

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg

PROMOTOR :

Prof. dr. Sven DE WEERDT

Inhoudsopgave

Woord vooraf	2
Abstract	3
1. Inleiding	4
2. Methode	5
3. Resultaten	8
3.1 Structuur bieden versus flexibiliteit behouden	8
3.2 Individuele besluitvorming versus collectieve betrokkenheid	8
3.3 Individuele begeleiding versus teamgerichte ondersteuning	9
3.4 Nabijheid versus autonomie stimuleren	10
3.5 Zorg dragen voor anderen versus zorg dragen voor zichzelf	10
3.6 Tempo maken versus vertragen	11
3.7 Vertrouwen uitstralen versus ervaren van onzekerheid	12
4. Discussie	13
4.1 Sterktes en limitaties	14
4.2 Aanbevelingen	15
5. Conclusie	16
6. Referenties	17
7. Bijlagen	19
7.1 Bijlage 1: Interviewgids	19
7.2 Bijlage 2: Paradoxen, thema's en subthema's	21
7.3 Bijlage 3: Schema thema's en subthema's per profiel en per ziekenhuis	24

Woord vooraf

Deze masterproef vormt het einde van een leerrijk traject binnen mijn opleiding proces- en systeeminnovatie in de gezondheidszorg. In dit traject heb ik mij verder kunnen verdiepen in leiderschap en opgelegde verandering binnen de gezondheidszorg.

Graag wil ik een aantal personen bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze masterproef.

In de eerste plaats wil ik mijn promotor, prof. dr. Sven De Weerdt, bedanken voor de begeleiding en de waardevolle feedback gedurende dit onderzoek. Verder wil ik ook alle respondenten bedanken die hun ervaringen en inzichten met mij deelden. Hun openheid vormde een belangrijke basis voor dit onderzoek.

Dank ook aan mijn collega's en leidinggevendenden binnen het Ziekenhuis Oost-Limburg voor de opportuniteit en ondersteuning om deze opleiding tot een goed einde te kunnen brengen. In het bijzonder wil ik mijn echtgenoot en kinderen bedanken voor hun steun, begrip en geduld. Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun betrokkenheid en aanmoediging tijdens deze uitdagende combinatie van studie, werk en privéleven.

Ik hoop dat dit onderzoek kan bijdragen aan een beter inzicht in leiderschap bij opgelegde veranderingen binnen de ziekenhuiscontext.

Jorien Stassen

Abstract

Introductie: Gezondheidszorgorganisaties bevinden zich in een context van voortdurende verandering gekenmerkt door sterke professionele autonomie, gefragmenteerde structuren en een cultuur waarin afdelingsgericht werken centraal staat. Deze kenmerken maken veranderingen in ziekenhuizen complexer dan in andere sectoren. Bovendien zorgt het toenemende tekort aan verpleegkundigen voor bijkomende uitdagingen waardoor ziekenhuizen genoodzaakt zijn om twee verblijfsafdelingen samen te voegen tot één verblijfsafdeling. Deze verandering wordt vaak top-down opgelegd. Hoofdverpleegkundigen spelen een cruciale rol in het implementeren van dergelijke veranderingen maar er is weinig bekend over de strategieën die gehanteerd worden en welke strategieën faciliteren om opgelegde veranderingen door te voeren. Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de rol van hoofdverpleegkundigen bij de opgelegde verandering, het samenvoegen van twee verblijfsafdelingen tot één afdeling en de strategieën die hierin faciliteren.

Methode: Voor dit onderzoek werd een hermeneutisch fenomenologisch design toegepast. Semi-gestructureerde interviews werden afgenomen bij 13 participanten (hoofdverpleegkundigen, adjunct-hoofdverpleegkundigen, managers, stafmedewerkers en verpleegkundigen) uit drie verschillende ziekenhuizen waar verblijfsafdelingen recent zijn samengevoegd. De inclusiecriteria omvatten onder meer: werkzaam in een ziekenhuis, betrokken bij het samenvoegen van verblijfsafdelingen en een minimumleeftijd van 18 jaar. De interviews werden letterlijk getranscribeerd of uitgewerkt in gedetailleerde notities en geanalyseerd via thematische analyse. De betrouwbaarheid van het onderzoek werd gewaarborgd door toepassing van COREQ-criteria, triangulatie en reflexiviteit.

Resultaten: De resultaten tonen aan dat leiderschap bij de opgelegde verandering niet kan worden herleid tot een vast stappenplan. De verschillende actoren ervaren de rol van hoofdverpleegkundigen als het gelijktijdig hanteren van organisatorische, relationele en psychologische spanningsvelden. Deze spanningsvelden uiten zich in het evenwicht behouden tussen structuur en flexibiliteit, individuele besluitvorming en collectieve betrokkenheid, individuele begeleiding en teamgerichte ondersteuning, nabijheid en autonomie stimuleren, zorg dragen voor anderen en zorg dragen voor zichzelf, tempo maken en vertragen en het uitstralen van vertrouwen ondanks het ervaren van onzekerheid.

Conclusie: Dit onderzoek toont aan dat leiderschap bij opgelegde verandering een dynamisch en contextgevoelig proces is waarin hoofdverpleegkundigen voortdurend moeten afwegen, schakelen en bijsturen. Het succes blijkt niet enkel afhankelijk te zijn van de inhoud van de verandering maar in belangrijke mate van hoe deze door de hoofdverpleegkundigen wordt vertaald, gedragen en gestuurd op afdelingsniveau. Hoofdverpleegkundigen vervullen hierbij een sleutelrol als verbindingsfiguur tussen beleid en praktijk waarbij hun vermogen om spanningsvelden te hanteren bijdraagt aan een gedragen en duurzame verandering binnen de ziekenhuiscontext. De bevindingen van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor onderzoek, praktijk en beleid door te verduidelijken hoe leiderschap bij opgelegde veranderingen vorm krijgt en welke condities duurzame verandering in ziekenhuizen ondersteunen.

Trefwoorden: Opgelegde verandering, verpleegkundig leiderschap, ziekenhuis, veranderingsmanagement, spanningsvelden

1. Inleiding

Gezondheidszorgorganisaties zijn een constant veranderende en uitdagende omgeving (1). Verandering in de gezondheidszorg is uitdagend omdat deze organisaties, waaronder ziekenhuizen, gekenmerkt worden door een sterke professionele autonomie, gefragmenteerde structuren en een cultuur waarin afdelingsgericht werken en denken centraal staat (2, 3). Bovendien volgen veranderingen elkaar steeds sneller op (2, 3). In vergelijking met andere organisaties verlopen veranderingen in ziekenhuizen doorgaans moeilijker omwille van verschillende eigenschappen zoals politieke structuren, de aanwezigheid van meerdere stakeholders en het multidimensionaal karakter (4).

Daarnaast verandert ook de zorgcontext ingrijpend. Recente rapporten tonen aan dat ziekenhuizen geconfronteerd worden met een structureel tekort aan verpleegkundigen waardoor het steeds moeilijker wordt om de toenemende zorgvraag op te vangen (5, 6). Deze zorgvraag blijft stijgen als gevolg van maatschappelijke evoluties zoals de vergrijzing en de toenemende complexiteit van zorg terwijl het beschikbare verpleegkundig personeel onvoldoende meegroeit. Tabel 1 geeft een overzicht van de verwachte evolutie van het verpleegkundig personeelsbestand in Vlaanderen tussen 2021 en 2046 (5). Hoewel het aantal verpleegkundigen toeneemt, blijkt dat deze groei onvoldoende is om de toenemende zorgbehoeften te blijven beantwoorden (5, 6). Hierdoor ontstaat een aanhoudende spanning tussen beschikbare personeelscapaciteit en de zorg die geleverd moet worden.

Tabel 1: Evolutie van het personeelsbestand van verpleegkundigen (gewogen dichtheden) tussen 2021 en 2046 voor de Vlaamse Gemeenschap volgens sector (5).

VLAAMSE GEMEENSCHAP						
	Actief Gezondheid - aantal			Actief Gezondheid – gewogen dichtheid		
Basisscenario	2021	2046	2021-2046 (%)	2021	2046	2021-2046 (%)
Professionele status	82.105	91.985	12,03	119,46	96,70	-19,05
Ziekenhuis	46.485	48.036	3,34	67,64	56,63	-16,27
Woonzorg-centrum	14.665	18.961	29,30	21,34	15,25	-28,55
Thuiszorg	15.829	19.749	24,76	23,03	18,96	-17,68
Maatschappij en Gezondheid	8.351	9.113	9,12	12,15	12,03	-0,98

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, kiezen ziekenhuizen steeds vaker voor het samenvoegen van verblijfsafdelingen. Deze verandering wordt doorgaans van hogerop, top-down, beslist, waar het team en de hoofdverpleegkundige geen vragende partij voor zijn. Er is dus sprake van een opgelegde verandering.

Hoofdverpleegkundigen binnen verblijfsafdelingen zijn verantwoordelijk om veranderingen door te voeren die de organisatie helpen bij het bereiken van hun doelen (1, 7, 8). Het leiden van veranderingen vormt de kern van leiderschap (8, 9). Verpleegkundig leiderschap, gedefinieerd als de capaciteit om medewerkers te coachen, te begeleiden om het vooropgestelde doel te behalen (10, 11), is een belangrijke factor voor het welslagen van de verandering (9).

Hoofdverpleegkundigen worden vaak gezien als veranderaars ondanks dat de verandering van hogerop opgelegd wordt (12). Deze hoofdverpleegkundigen dienen de verandering operationeel te maken en fungeren als tussenpersoon tussen de directie/management en de verpleegkundigen (8, 12). Het uiteindelijke succes van de verandering hangt dan ook af van hoe de hoofdverpleegkundige de verandering doorvoert (12).

Wanneer veranderingen suboptimaal doorgevoerd worden, leidt dat tot onvoldoende gedragenheid en onnodige weerstand (2, 13). Daarnaast is weerstand tegen verandering niet alleen een onvermijdelijke factor maar ook een cruciale factor waar rekening mee gehouden dient te worden bij het doorvoeren van verandering (13).

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan veranderingsbereidheid, waaronder leiderschapsgedrag (12). Leiderschapsgedrag verwijst naar de variatie in leiderschapstijlen die in eerdere studies zijn onderzocht (10).

Naast leiderschapsgedrag worden veranderprocessen ook beïnvloed door vertrouwen in leiderschap en rolgerelateerde aspecten zoals duidelijke rolverwachtingen en rolconflict (14, 15).

Hoewel eerder onderzoek inzicht biedt in wat verandering in organisaties in gang zet en hoe veranderingsprocessen verlopen, is er minder bekend over welke strategieën hoofdverpleegkundigen inzetten bij opgelegde veranderingen (10). Daarbij is het waardevol om na te gaan welke strategieën hierin faciliteren.

Dit onderzoek heeft dan ook het doel om te onderzoeken welke strategieën hoofdverpleegkundigen hanteren bij de opgelegde verandering waarbij twee verblijfsafdelingen worden samengevoegd tot één verblijfsafdeling en welke strategieën hierin faciliteren.

Dit onderzoek draagt bij aan het inzicht hoe leiderschap bij de opgelegde verandering vorm krijgt en hoe dit kan bijdragen aan een gedragen duurzame implementatie in ziekenhuizen.

2. Methode

2.1 Studiedesign

Voor dit onderzoek werd een hermeneutisch fenomenologisch onderzoeksdesign gebruikt om te onderzoeken hoe hoofdverpleegkundigen hun rol binnen de opgelegde verandering hebben ervaren en welke betekenis hieraan werd toegekend. Daarnaast werd nagegaan hoe andere betrokken actoren betekenis geven aan het gedrag van de hoofdverpleegkundige. Dit onderzoek vertrekt vanuit de aanname dat verschillen in betekenisgeving tussen actoren, meer specifiek de interpretatie van elkaars gedrag, de implementatie van de opgelegde verandering kunnen bemoeilijken waarbij voldoende gedeelde betekenisgeving essentieel is. Om dit in kaart te brengen, werden semi-gestructureerde interviews afgenomen en werden de verzamelde data thematisch geanalyseerd. De geconsolideerde criteria voor het rapporteren van kwalitatief onderzoek (COREQ) werden gebruikt om de onderzoeksresultaten te rapporteren (16).

2.2 Steekproef en rekrutering

Participanten werden gerekruteerd via purposive sampling op basis van volgende inclusiecriteria: minimumleeftijd van 18 jaar, werkzaam in een ziekenhuis, betrokken bij een samengevoegde verblijfsafdeling waarvoor het onderliggende motief tekort aan verpleegkundigen is en de huidige functie is hoofdverpleegkundige, adjunct-hoofdverpleegkundige, verpleegkundige, manager of stafmedewerker is. De steekproefomvang voor dit onderzoek bestaat uit 13 participanten (n= 13) afkomstig uit drie verschillende ziekenhuizen. Een overzicht van de participanten karakteristieken wordt weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Karakteristieken van de participanten

n = 13	
Geslacht	
Man	3
Vrouw	10
Functie	
Hoofdverpleegkundige	4
Adjunct-hoofdverpleegkundige	1
Verpleegkundige	3
Manager	3
Stafmedewerker	2
Leeftijdscategorie (in jaren)	
21 - 29 jaar	1
30 - 39 jaar	4
40 - 49 jaar	3
50 - 59 jaar	2
60 - 65 jaar	2
Werkervaring	
Minimum	6 jaar
Maximum	42 jaar
Gemiddelde	21,4 jaar
Aantal jaren in huidige rol (in jaren)	
Minimum	2 jaar
Maximum	32 jaar
Gemiddelde	11,9 jaar

2.3 Datacollectie

De data werd verzameld via 13 semi-gestructureerde interviews, uitgevoerd tussen 12 februari en 16 april 2026 door één onderzoeker (SJ) in opleiding. De interviews vonden fysiek plaats in het ziekenhuis of online, afhankelijk van de voorkeur van de participant.

De meeste interviews werden opgenomen met behulp van een digitaal audio-opname apparaat. In situaties waarin audio-opnamen niet toegestaan waren, maakte deze onderzoeker tijdens het gesprek uitgebreid en zo volledig mogelijke notities, die onmiddellijk na afloop aangevuld en uitgewerkt werden. Op die manier werd dataverlies geminimaliseerd en werd de consistentie tussen beide dataverzamelmethode bewaakt. Aanvullend maakte deze onderzoeker tijdens alle interviews korte veldnotities om non-verbale observaties en relevante indrukken vast te leggen. Alle transcripties en uitgewerkte notities werden verwerkt door dezelfde onderzoeker.

Als leidraad tijdens deze interviews werd er gebruikgemaakt van een interviewgids, opgesteld met behulp van relevante literatuur (bijlage 1).

De duur van het interview varieerde tussen 38 en 80 minuten met een gemiddelde van 47 minuten. Elk interview vond éénmalig plaats.

2.4 Data-analyse

De data-analyse startte parallel met de datacollectie zodat inzichten uit de interviews konden bijdragen aan de verdere verfijning van de interviewgids. De transcripties werden geanalyseerd met behulp van NVivo® versie 15, volgens de thematische analysemethode van Braun en Clarke (17, 18).

De data-analyse verliep abductief waarbij een iteratieve beweging plaatsvond tussen de data en bestaande theoretische inzichten.

De transcripties werden herhaaldelijk gelezen en herlezen om vertrouwd te raken met de data en de eerste patronen te identificeren. Vervolgens werden betekenisvolle segmenten in de transcripties geïdentificeerd en gecodeerd over de volledige dataset, zonder differentiatie per rol of ziekenhuiscontext. De codes werden vervolgens gegroepeerd in potentiële subthema's. Tijdens dit proces werd voortdurend nagegaan in welke mate deze thema's een accurate en betekenisvolle weerspiegeling vormden van de oorspronkelijke data. In een volgende stap werd de analyse verdiept door de data systematisch te vergelijken tussen de verschillende rollen en ziekenhuiscontexten waarbij overeenkomsten, verschillen en spanningen in betekenisgeving werden geïdentificeerd. De inzichten werden vervolgens gesynthetiseerd in overkoepelende thema's die gedeelde patronen in betekenisgeving weerspiegelen. Deze thema's werden iteratief herzien, verfijnd en geïnterpreteerd als spanningsvelden. De uiteindelijke overkoepelende thematische paradoxen vormen het resultaat van dit onderzoek en worden beschreven en geïllustreerd met relevante citaten.

2.5 Kwaliteitscriteria

De kwaliteit van het onderzoek (*trustworthiness*) werd gewaarborgd door het toepassen van *credibility*, *confirmability*, *dependability*, *transferability* en *authenticity* (19).

Credibility werd versterkt door triangulatie waarbij binnen en tussen elk ziekenhuis verschillende perspectieven werden bevestigd en vergeleken. Dit maakte het mogelijk om ervaringen zowel binnen als tussen casussen te vergelijken. Daarnaast werd onderzoekstriangulatie toegepast doordat één interview door een tweede onderzoeker (DWS) onafhankelijk werd gecodeerd en de data-analyse gezamenlijk besproken werd.

Een systematische data-analyse droeg bij aan de *confirmability* van het onderzoek. Interviews werden waar mogelijk letterlijk getranscribeerd en wanneer audio-opname niet mogelijk was, uitgewerkt in uitgebreide notities. Op deze manier werd getracht de rijkheid en nauwkeurigheid van de data zo goed mogelijk te behouden.

Transparante methodologische procedures en een duidelijke contextbeschrijving van de ziekenhuizen ondersteunden *dependability* en *transferability*.

Authenticity werd gewaarborgd door het zorgvuldig weergeven van de perspectieven van de participanten.

Reflexiviteit vormde hierbij een belangrijk uitgangspunt. De student-onderzoeker schreef vooraf een persoonlijk referentiekader uit en reflecteerde voortdurend op de eigen rol en mogelijke invloed op de interpretatie van de data.

2.6 Ethische overweging

Ethische goedkeuring werd bekomen bij de bevoegde Commissie voor Medische Ethiek van de Universiteit Hasselt (CME2026/004) en de betrokken ziekenhuizen. De participanten werden vooraf geïnformeerd over het onderzoeksdoel, onderzoeksmethode, anonimiteit en vertrouwelijkheid. Deelname was vrijwillig en kon op elk moment stopgezet worden zonder consequenties. Alle participanten gaven geïnformeerde toestemming.

3. Resultaten

Ondanks dat er 14 thema's werden geïdentificeerd, laat leidinggeven bij opgelegde verandering zich niet herleiden tot eenduidige strategieën. De analyse toont dat thema's vaak tegengesteld zijn en spanningsvelden vormen. Om deze complexiteit zichtbaar te maken, worden de resultaten beschreven aan de hand van paradoxen die meerdere thema's samenbrengen en het voortdurend zoeken naar een werkbare balans weerspiegelen.

3.1 Structuur bieden versus flexibiliteit behouden

Het aanbrengen van structuur wordt gezien als een essentieel onderdeel van het omgaan met de opgelegde verandering. Dit uit zich in het expliciteren van prioriteiten, het uitwerken van een plan van aanpak en het creëren van werkbare processen die houvast bieden aan medewerkers. Op die manier wordt getracht om de complexiteit te reduceren en duidelijkheid te scheppen. Het ontbreken van structuur bemoeilijkt het dagelijks functioneren en wordt als noodzakelijk ervaren terwijl deze in een veranderende en onvoorspelbare context niet vanzelfsprekend tot stand komt.

"Als wij dan naar de andere afdeling moesten die in het begin nog niet gestructureerd was, was dat heel moeilijk werken." (verpleegkundige)

Daarnaast wordt er gewezen op het belang van contextanalyse. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, bestaat het risico dat veranderingen te snel worden vastgelegd zonder voldoende afstemming op de specifieke situatie.

"Ik denk dat ze soms nog te weinig contextanalyse doen en al te veel bepalen: dit moet het zijn." (hoofdverpleegkundige)

Hierbij wordt benadrukt dat het gebruik van implementatiekaders helpend kan zijn.

"Ik geloof zelf heel erg in implementatiekaders (...) waarin heel duidelijk is wat je kerncomponenten zijn." (hoofdverpleegkundige)

Tegelijkertijd wordt er gewezen op het belang van het voortdurend bijsturen van het plan van aanpak.

"We zijn wel een beetje afgeweken van het scenario (...) dus we hebben dat aangepast en dat is eigenlijk goed verlopen." (hoofdverpleegkundige)

Binnen dit spanningsveld zijn er duidelijke verschillen zichtbaar tussen de verschillende profielen, die in alle drie de casussen naar voren komen. Managers en stafmedewerkers leggen de nadruk op het uitzetten van beleidsmatige kaders en ontwikkelen van plannen. Hoofdverpleegkundigen en adjunct-hoofdverpleegkundigen richten zich op het vertalen van deze kaders naar werkbare structuren op afdelingsniveau waarbij het voortdurend bijsturen van de aanpak wordt benoemd als een noodzakelijke voorwaarde om de verandering te implementeren. Verpleegkundigen ervaren structuur voornamelijk als duidelijkheid in verwachtingen en afspraken maar benadrukken tegelijkertijd het belang van autonomie in het dagelijkse werk.

3.2 Individuele besluitvorming versus collectieve betrokkenheid

Participanten beschrijven leiderschap bij een opgelegde verandering als een spanningsveld tussen het individueel opnemen van verantwoordelijkheid en het creëren van collectieve betrokkenheid. In situaties van onzekerheid of tijdsdruk is het soms noodzakelijk om als hoofdverpleegkundige positie in te nemen en duidelijk richting te geven.

"Waarbij je soms moet durven als een kapitein op je schip te gaan staan en zeggen: nee, dat gaan we niet doen." (hoofdverpleegkundige)

Tegelijk wordt er benadrukt dat beslissingen enkel worden aanvaard wanneer deze niet als impulsief maar als doordacht en gericht op het collectieve belang van het team worden ervaren.

"Waarbij ze ook wel altijd snapten dat als ik een beslissing nam dat dat nooit zo halsoverkop was. En dat dat altijd in belang was van de groep." (hoofdverpleegkundige)

Richting geven blijkt pas effectief wanneer er gedragenheid ontstaat binnen het team. Hoofdverpleegkundigen kunnen als individu zaken uitzetten en voorbereiden maar de daadwerkelijke beweging wordt in gang gezet door het geloof en engagement van medewerkers.

"Want je kan als leidinggevende wel dingen uitzetten en uitwerken maar het is die gedragenheid, dat geloof bij uw team wat maakt dat je elkaar eigenlijk wel ontmoet en dat je elkaar ook in de kracht zet." (hoofdverpleegkundige)

Deze combinatie maakt duidelijk dat individueel knopen doorhakken en samenwerken geen tegengestelde acties zijn maar complementaire bewegingen die samen richting geven aan effectief leiderschap bij de opgelegde verandering.

De wijze waarop deze paradox wordt ervaren en ingevuld, verschilt naargelang het profiel. Managers beschrijven individueel beslissen als noodzakelijk om richting en duidelijkheid te creëren.

"Daar is vaak gewoon echt een leidinggevende nodig die zegt van kijk, zo gaan we nu starten." (manager)

Collectieve betrokkenheid wordt gesitueerd in de fase na het besluit met het oog op uitvoering.

"Soms naar geluisterd en soms ook gezegd het is goed voor vandaag. Soms is het ook afbakenen: ik weet uw bezorgdheid... maar wat ik van jullie wil, is goede zorg voor de patiënten." (manager)

Hoofdverpleegkundigen ervaren dit spanningsveld het meest intens aangezien deze functie zich situeert op het kruispunt van formele beslissingsverantwoordelijkheid en nabijheid tot het team. Dit wordt beschreven als een voortdurende afweging tussen richting geven en het bewaken van betrokkenheid.

"Gezegd dat ze het moesten proberen. Als het echt niet ging, dan konden we aanpassingen doen. Maar wel met de boodschap: geef het even tijd en probeer het maar." (hoofdverpleegkundige)

Verpleegkundigen erkennen de nood aan duidelijke beslissingen maar koppelen hun bereidheid om te volgen sterk aan de mate waarin ze betrokken worden en vertrouwen in de hoofdverpleegkundige. Wanneer beslissingen worden ervaren als doordacht en genomen in het belang van het team ontstaat er aanvaarding en bereidheid om er samen aan te werken.

3.3 Individuele begeleiding versus teamgerichte ondersteuning

Participanten geven aan dat opgelegde verandering vraagt om een voortdurende afweging tussen het begeleiden van individuele medewerkers en het ondersteunen van het team als geheel, waarbij hoofdverpleegkundigen bewust schakelen tussen individuele aandacht en collectieve focus.

"Balanceren tussen je richten op één medewerker en het bieden van coaching en vervolgens opnieuw schakelen naar het team." (hoofdverpleegkundige)

Individuele begeleiding wordt beschreven als noodzakelijk om in te spelen op persoonlijke noden, onzekerheden en verschillen in tempo.

"Iedereen ook een beetje op zijn of haar maat." (hoofdverpleegkundige)

Tegelijk wordt benadrukt dat verandering niet uitsluitend op individueel niveau kan worden gedragen. Wanneer de aandacht te sterk naar individuele trajecten verschuift, dreigt het teamproces onder druk te staan. Teamgerichte ondersteuning wordt daarom beschouwd als essentieel om samenhang en een gedeeld tempo te behouden.

Deze paradox wordt vooral sterk ervaren door hoofdverpleegkundigen en adjunct-hoofdverpleegkundigen die zich dagelijks bevinden op het snijvlak van individuele begeleiding en teamwerking. Verpleegkundigen ervaren individuele begeleiding als waardevol wanneer dit niet losstaat van het teamproces maar bijdraagt aan gezamenlijke groei.

Individuele begeleiding en teamgerichte ondersteuning worden daarbij niet als tegengestelde benaderingen ervaren maar als onderling afhankelijke bewegingen binnen hetzelfde veranderproces.

3.4 Nabijheid versus autonomie stimuleren

Tijdens het proces van de opgelegde verandering wordt bewust nabijheid gecreëerd door als hoofdverpleegkundige tijdelijk mee te stappen in het dagelijkse werk. Meewerkend leiderschap wordt hierbij niet opgevat als een structurele verschuiving naar operationeel functioneren maar als een tijdelijke en doelgerichte interventie.

Door aanwezig te zijn op momenten dat het moeilijk loopt, dragen hoofdverpleegkundigen het veranderproces mee en staan medewerkers er niet alleen voor.

Deze nabijheid wordt als belangrijk ervaren.

"Dat is wel belangrijk als leidinggevende, dat je echt zo mee in die verandering durft te gaan en dat je er even in staat." (manager)

Tegelijkertijd wordt benadrukt dat deze manier van werken niet blijvend kan of hoeft te zijn. Naarmate het team meer houvast opbouwt, ontstaat er ruimte om verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij medewerkers te stimuleren. Autonomie wordt daarbij niet gezien als het wegvallen van ondersteuning maar als het actief bevorderen van initiatief en probleemoplossend vermogen.

"Probeer maar. Doe maar eens iets. Daar lopen we tegenaan en hoe kunnen we dat samen oplossen als team?" (adjunct-hoofdverpleegkundige)

Nabijheid en het stimuleren van autonomie vormen daarbij geen opeenvolgende fasen maar een dynamisch proces waarin voortdurend gebalanceerd wordt tussen ondersteunen en loslaten.

Binnen deze paradox ligt het verschil tussen de actoren niet zozeer in het al dan niet inzetten van meewerkend leiderschap maar in de betekenis die eraan gegeven wordt. Managers positioneren meewerken als een instrument dat strategisch en tijdelijk wordt ingezet, terwijl hoofdverpleegkundigen dit invullen als een situationeel en dynamisch proces waarin voortdurend gebalanceerd wordt tussen nabijheid en autonomie. Verpleegkundigen beleven het als een steunende en verbindende vorm van leidinggeven die het opnemen van verantwoordelijkheid bevordert en fungeert als relationele basis voor vertrouwen en autonomie.

3.5 Zorg dragen voor anderen versus zorg dragen voor zichzelf

De rol van de hoofdverpleegkundigen bij de opgelegde verandering wordt ervaren als gericht op het ondersteunen en versterken van het team. Verandering vraagt veel van medewerkers waardoor het belangrijk is om teams te ondersteunen en hun draagkracht te bewaken. Dit wordt beschreven als het zoeken naar een evenwicht waarbij vooruitgang mogelijk blijft zonder overbelasting.

"Je moet zorgen dat die wagonnetjes het blijven trekken, maar zonder dat ze zich oververhitten." (hoofdverpleegkundige)

Veerkracht wordt hierbij niet gezien als een statische eigenschap maar als iets dat geleidelijk kan worden opgebouwd binnen het team.

"Ik denk dat je veerkracht opbouwt in je team. En op zo momenten voel je wat het effect is van de inspanningen. Als je een heel veerkrachtig team hebt, dan kunnen zij dat wel." (hoofdverpleegkundige)

Leiderschap richt zich hier niet op het voortdurend overnemen maar op het versterken van het collectieve vermogen van teams om met druk en verandering om te gaan.

Opvallend is dat de zorg voor de draagkracht van de hoofdverpleegkundigen niet door hoofdverpleegkundigen wordt benoemd en vaker naar voren komt vanuit het perspectief van stafmedewerkers. Vanuit dit perspectief wordt benadrukt dat opgelegde verandering niet alleen impact heeft op teams maar ook op hoofdverpleegkundigen die langdurig onder spanning staan en meerdere verantwoordelijkheden combineren. Het belang van ondersteuning, begeleiding en het tijdig bewaken van grenzen bij hoofdverpleegkundigen om hen in staat te stellen dit vol te houden wordt daarbij naar voren geschoven.

Deze bevindingen maken duidelijk dat het spanningsveld tussen zorg voor het team en zorgen voor zichzelf niet door één actor volledig wordt benoemd.

Hoofdverpleegkundigen richten zich voornamelijk op het versterken van de draagkracht van het team terwijl stafmedewerkers expliciet de belasting van de hoofdverpleegkundige zelf en de nood aan ondersteuning naar voren brengen.

3.6 Tempo maken versus vertragen

Participanten beschrijven de opgelegde verandering als een proces waarin hoofdverpleegkundigen voortdurend balanceren tussen de druk om vooruitgang te realiseren en het besef dat verandering tijd vraagt om te kunnen landen. Er worden verwachtingen ervaren vanuit de organisatie om veranderingen snel door te voeren en het tempo hoog te houden. Deze snelheid wordt niet altijd als haalbaar ervaren omdat het opgelegde tempo niet automatisch aansluit bij het tempo dat medewerkers kunnen volgen.

“Want natuurlijk een organisatie gaat of wil soms sneller gaan dan jij zou kunnen volgen.”
(hoofdverpleegkundige)

Daarnaast komt naar voren dat tempo niet voor iedereen hetzelfde is waardoor het noodzakelijk is om het tempo voortdurend af te stemmen.

“De snelheid waarmee dat jij kan gaan en ik kan gaan, is dikwijls wel verschillend.”
(hoofdverpleegkundige)

Ook wordt benadrukt dat verandering niet in één beweging kan worden gerealiseerd.

“Je moet wel niet ineens de weg willen afleggen naar dat groot doel.” (hoofdverpleegkundige)

Dit wijst op een stapsgewijze benadering van verandering waarin forceren het risico inhoudt dat medewerkers afhaken.

Managers geven aan dat tempo maken niet alleen een individuele keuze is maar ontstaat in de wisselwerking tussen verwachtingen vanuit de organisatie en de operationele realiteit.

“Ik denk dat we het soms wat minder doen [als het gaat over] de snelheid, maar ja, soms worden we ook gepusht in snelheid.” (manager)

Vanuit het perspectief van verpleegkundigen wordt vertragen aangegeven als noodzakelijk om verandering werkbaar te houden. Er is begrip voor de wens om snel resultaten te zien maar verpleegkundigen benadrukken dat wennen en meegroeien tijd vraagt.

“Ik snap dat je het vlot wil laten verlopen en hoe rapper hoe liever maar ik denk dat je dat ook allemaal wat tijd moet geven.” (verpleegkundige)

Een te hoog tempo houdt het risico in dat verandering als onhaalbaar wordt ervaren. Zichtbaar vertragen is soms noodzakelijk om te vermijden dat het veranderproces vastloopt.

“Ze wilden snel gaan maar medewerkers gaven aan dat dit zo niet zou lukken en dat het tempo moest worden teruggeschroefd. Als je dat doorduwt, dan gaat die verandering gewoon niet slagen.” (manager)

Hoofdverpleegkundigen beschrijven vertragen daarom niet als stilstand maar als een bewuste leiderschapskeuze. Het tijdelijk halt houden wordt ingezet om af te stemmen en het draagvlak te herstellen. Hierbij wordt het beeld beschreven van wachten zonder falen waarbij vertragen de betekenis krijgt van actief reguleren van het veranderproces.

“Dan sta ik stil in het stationnetje en denk ik: oei, nu moeten we even wachten. Maar er is ook niks mis met wachten.” (hoofdverpleegkundige)

Ten slotte tonen voornamelijk hoofdverpleegkundigen aan dat tempo niet alleen intern gereguleerd moet worden maar dat tijd ook als conditie moet worden benoemd richting de organisatie. Wanneer het tempo te hoog ligt, wordt het noodzakelijk geacht om aan te geven dat voldoende tijd een randvoorwaarde is om medewerkers te laten volgen en verandering duurzaam te verankeren.

Tijd wordt hierdoor gepositioneerd als een beschermende factor en niet als weerstand tegen verandering.

Leiderschap bij opgelegde verandering situeert zich daarmee in een spanningsveld waarin tempo maken, vertragen en het aangeven van tijd als conditie samenkomen. Door tempo actief te reguleren trachten hoofdverpleegkundigen zowel beweging te behouden als betrokkenheid en verankering mogelijk te maken.

3.7 Vertrouwen uitstralen versus ervaren van onzekerheid

Het opgelegde karakter van de verandering maakt dat hoofdverpleegkundigen niet altijd volledige zeggenschap hebben over de uitgangspunten of het ontwerp van de verandering terwijl tegelijk verwacht wordt dat hoofdverpleegkundigen vertrouwen en overtuiging uitstralen naar hun team.

Binnen dit spanningsveld komt naar voren dat hoofdverpleegkundigen eerst zelf betekenis moeten geven aan de verandering alvorens dit vertrouwen extern uitdragen kan worden.

"Er zelf in geloven als leidinggevende. Want het is langs de ene kant nog opgelegd vanuit het ziekenhuis. We proberen het nu samen te doen. Proberen erin te geloven dat wat ze bedacht hebben ook gaat werken." (adjunct-hoofdverpleegkundige)

Dit maakt duidelijk dat vertrouwen uitstralen niet vanzelfsprekend is maar voorafgaat aan een intern proces van zoeken naar aansluiting bij de verandering.

Tegelijk wordt er weergegeven dat vertrouwen uitstralen niet betekent dat hoofdverpleegkundigen geen onzekerheid ervaren. Twijfel en momenten van aarzeling zijn inherent aan de opgelegde verandering. Leiderschap krijgt hier vorm door ondanks deze onzekerheid te blijven geloven in de gekozen richting en dit vertrouwen zowel intern te bewaren als naar het team toe uit te dragen.

"Blijven geloven in de weg vooruit, ook wanneer successen uitblijven of het proces moeizaam verloopt." (hoofdverpleegkundige)

Daarnaast komt het verschil naar voren tussen geloven in wat moet veranderen en geloven in waarom er veranderd wordt. Vertrouwen uitstralen blijkt vooral mogelijk wanneer hoofdverpleegkundigen zich blijven verbinden met de onderliggende betekenis van de verandering.

"Niet alleen in de wat geloven, maar ook in de waarom. Waarom doen we dat?" (hoofdverpleegkundige)

Het geloof in het "waarom" fungeert als houvast op momenten van onzekerheid.

Verder wordt duidelijk dat vertrouwen uitstralen hand in hand gaat met doorzetten zonder te ontkennen dat verandering gepaard gaat met vallen en opstaan.

"Oké, dat lukt ons misschien niet van de eerste keer goed, maar dat gaat ons wel lukken." (hoofdverpleegkundige)

Vertrouwen uitstralen betekent hier niet het ontkennen van moeilijkheden maar het behouden van perspectief en richting ondanks tegenslagen. Deze psychologische spanning blijkt nauw verweven met alle andere paradoxen in dit hoofdstuk. Het hanteren van structuur, het nemen van beslissingen, het reguleren van tempo en het begeleiden van teams veronderstelt telkens dat hoofdverpleegkundigen intern onzekerheid ervaren terwijl ze extern vertrouwen blijven uitstralen. Deze paradox vormt daarmee een onderliggende laag die het hanteren van andere spanningsvelden mogelijk maakt.

4. Discussie

Dit onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de rol van de hoofdverpleegkundige bij de opgelegde verandering en welke strategieën hierin faciliteren. De resultaten tonen aan dat leiderschap in deze context niet kan worden herleid tot een vaste aanpak of lineaire stappen maar krijgt vorm in het gelijktijdig hanteren van meerdere spanningsvelden op organisatorisch, relationeel en psychologisch niveau.

Deze bevinding sluit aan bij literatuur die stelt dat verandering in de gezondheidszorg gekenmerkt wordt door complexiteit, onzekerheid en interacties tussen verschillende actoren (2, 4).

De geïdentificeerde paradoxen in dit onderzoek kunnen daarbij begrepen worden vanuit het perspectief van paradoxaal leiderschap waarbij tegenstrijdige maar onderling afhankelijke elementen simultaan aanwezig zijn en geïntegreerd moeten worden (20-22). Dit impliceert dat effectief leiderschap niet bestaat uit het maken van keuzes tussen tegenpolen maar uit het continu zoeken naar een werkbare balans tussen beide.

Op organisatorisch niveau balanceren hoofdverpleegkundigen tussen het bieden van structuur en het behouden van flexibiliteit evenals tussen tempo maken en bewust vertragen.

De nood aan structuur sluit aan bij literatuur die het belang van doelen, rollen en processen benadrukt om onzekerheid te reduceren en richtinggevend kader bieden dat gecoördineerd handelen mogelijk maakt (15). Tegelijkertijd tonen de resultaten aan dat structuur binnen een dynamische context niet rigide kan worden toegepast. Gezondheidszorgsystemen functioneren als complex adaptieve systemen, waarin veranderingen zich niet lineair ontwikkelen maar emergent en situationeel verlopen (23). Dit impliceert dat vooraf vastgelegde procedures en plannen slechts beperkte waarde hebben wanneer deze niet voortdurend worden aangepast aan wat zich in de praktijk voordoet (24). Binnen dit spanningsveld kunnen implementatiekaders, meer specifiek *determinant frameworks*, een rol spelen. Hierdoor wordt het mogelijk om contextgebonden factoren systematisch te identificeren en implementatiestrategieën af te stemmen op de specifieke situatie (25).

Daarnaast is er op organisatorisch niveau ook een spanning tussen tempo maken en bewust vertragen. Hoofdverpleegkundigen ervaren druk om de opgelegde verandering snel te realiseren onder meer door organisatorische verwachtingen, beleidsmatige deadlines en de brede context van schaarste en systeemdruk (5, 6). Hoewel tempo voortgang zichtbaar maakt, brengt een te hoog tempo het risico met zich mee dat de verandering onvoldoende wordt gedragen en slechts oppervlakkig wordt doorgevoerd. Snelle, top-down ingevoerde veranderingen kunnen leiden tot terughoudendheid, emotionele belasting en het vasthouden aan bestaande routines (2). Verandering in de gezondheidszorg laat zich niet reduceren tot lineaire tijdslijnen maar wordt beïnvloed door meerdere temporele dimensies, namelijk aspecten die betrekking hebben op hoe verandering zich in de tijd ontwikkelt (26). Dit omvat onder meer de snelheid van de verandering (tempo) en timing (moment van implementatie) (26). Vanuit dit perspectief kan weerstand ontstaan wanneer het opgelegde tempo vanuit de organisatie niet aansluit bij het ritme waarin medewerkers hun werk uitvoeren (27). In lijn hiermee krijgt bewust vertragen betekenis als een strategie om ruimte te creëren voor betekenisgeving, afstemming en duurzame verandering en verankering (26, 27).

Op relationeel niveau komt leiderschap naar voren als een spanningsveld tussen individuele besluitvorming en collectieve betrokkenheid. Hoofdverpleegkundigen worden geconfronteerd met de nood om, vanuit hun formele rol, beslissingen te nemen terwijl de effectiviteit ervan afhankelijk is van de mate waarin medewerkers zich betrokken en gehoord voelen. Dit bevestigt dat leiderschap in verandercontexten niet enkel bestaat uit besluitvorming maar uit het relationeel legitimeren ervan via dialoog en interactie met medewerkers (20). Betrokkenheid ontstaat niet door het louter meedelen van beslissingen maar groeit wanneer medewerkers ruimte ervaren om vragen te stellen en bezorgdheden te uiten. Door actief te luisteren en in dialoog te gaan, ondersteunen hoofdverpleegkundigen medewerkers in het begrijpen van de verandering wat bevestigt dat verandering vooral tot stand komt via interactie en gesprekken tussen hoofdverpleegkundigen en medewerkers (28).

Daarnaast is er een tweede relationeel spanningsveld, namelijk nabijheid versus autonomie. Tijdens de opgelegde verandering zetten hoofdverpleegkundigen bewust in op nabijheid, onder meer door aanwezig te zijn in het dagelijkse werk van het team. Dit kan worden begrepen als een vorm van leiderschap dat medewerkers ondersteunt bij onzekerheid en het omgaan met de complexiteit van de opgelegde verandering (29).

Door zichtbaar aanwezig te zijn en verantwoordelijkheid mee op te nemen, tonen hoofdverpleegkundigen dat het veranderproces mee gedragen wordt en dat medewerkers er niet alleen voor staan. Deze nabijheid versterkt het vertrouwen wat aansluit bij de literatuur die stelt dat vertrouwen in leiderschap ontstaat door concreet leiderschap en relationeel gedrag dat zich ontwikkelt via interactie (14). Naarmate het team meer houvast en vertrouwen heeft opgebouwd, verschuift het accent geleidelijk en ontstaat er meer ruimte voor autonomie, zonder dat nabijheid volledig verdwijnt. Autonomie wordt daarbij niet ervaren als het wegvallen van ondersteuning maar als een proces waarin medewerkers initiatief en eigenaarschap opnemen (14). Dit suggereert dat nabijheid en autonomie overlappende aspecten zijn die in intensiteit verschuiven doorheen de tijd, waarbij elementen van het andere aspect aanwezig blijven.

Effectief leiderschap vraagt daarom om een flexibele afstemming tussen beide.

Ten slotte doet zich een derde relationeel spanningsveld voor tussen individuele begeleiding en teamgerichte ondersteuning. In de literatuur wordt leiderschap hierbij omschreven als gericht op zowel het individuele als het teamniveau, waardoor beide niveaus tegelijk aangesproken worden (30).

Naast organisatorische en relationele spanningen brengen opgelegde veranderingen ook psychologische uitdagingen met zich mee voor hoofdverpleegkundigen. Leiderschap in deze verandercontext heeft ook een innerlijk karakter waarbij verwacht wordt dat hoofdverpleegkundigen hun emoties en overtuigingen reguleren in functie van de eisen van hun rol.

Een eerste psychologisch spanningsveld betreft het uitstralen van vertrouwen terwijl hoofdverpleegkundigen zelf geconfronteerd worden met onzekerheid. Deze spanning toont dat het reguleren van een gevoel van onzekerheid een voorwaarde vormt om vertrouwen naar het team toe te kunnen uitstralen. Dit kan worden begrepen vanuit rolambigüiteit, onduidelijke verwachtingen en veranderende rollen die samengaan met de nood om richting en stabiliteit te bieden (15). Het uitstralen van vertrouwen vereist hierbij emotionele arbeid: het reguleren van eigen gevoel van onzekerheid en twijfel om vertrouwen en houvast te kunnen bieden aan anderen (31). Vertrouwen uitstralen betekent daarbij niet dat er volledige zekerheid is, maar dat hoofdverpleegkundigen voldoende houvast hebben om toch doelgericht te blijven handelen in een onzekere situatie.

Een tweede psychologisch spanningsveld betreft het zorg dragen voor medewerkers versus zorg dragen voor zichzelf. Het inzetten op ondersteuning en het opvangen van emoties binnen het team gaat gepaard met emotionele belasting. Deze spanning wordt mede verklaard doordat zorgend en relationeel leiderschap een kernonderdeel vormt van hun professionele rol. Voor hoofdverpleegkundigen betekent dit niet alleen het bepalen van de toon binnen de afdeling maar ook het actief ondersteunen van medewerkers en waken over professionele zorg (32). Wanneer deze rol kan worden opgenomen in overeenstemming met persoonlijke waarden gaat dit doorgaans gepaard met hogere jobtevredenheid en lagere stressniveaus (31). Deze rol kan begrepen worden als het reguleren van zowel de eigen emoties als die van anderen om vertrouwen, stabiliteit en motivatie te behouden. Deze regulatie vraagt een aanzienlijke psychologische investering die bij onvoldoende herstel of ondersteuning kan leiden tot spanning met de eigen draagkracht (31, 33).

De vastgestelde verschillen in hoe leiderschap bij de opgelegde verandering wordt ervaren tussen de verschillende actoren en ziekenhuiscontexten wijzen erop dat leiderschap contextafhankelijk en relationeel wordt vormgegeven. Hoofdverpleegkundigen functioneren hierbij als sleutelfiguur die voortdurend proberen om te gaan met organisatorische, relationele en psychologische spanningsvelden. De variatie tussen casussen onderstreept dat leiderschap niet louter voortkomt uit individuele competenties maar mede vorm krijgt in interactie met de specifieke organisatiecontext.

4.1 Sterktes en limitaties

Dit onderzoek kent enkele limitaties die in acht genomen moeten worden bij de interpretatie van de resultaten. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen drie ziekenhuizen waarbij telkens één casus werd onderzocht waarbij twee verblijfseenheden werden samengevoegd. In één ziekenhuis was deze samenvoeging van tijdelijke aard wat invloed gehad kan hebben op hoe de verschillende actoren van dit ziekenhuis het veranderproces hebben ervaren.

Daarnaast is het onderzoek gebaseerd op zelfgerapporteerde ervaringen en percepties van betrokken actoren. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat antwoorden beïnvloed worden door sociaal wenselijk antwoordgedrag of selectieve herinnering waarbij gebeurtenissen achteraf worden geïnterpreteerd in functie van het verloop van de verandering. Om de impact hiervan te beperken werden meerdere perspectieven betrokken en werden verschillen en overeenkomsten in ervaringen tussen de participanten geanalyseerd.

Een sterkte van dit onderzoek is de samenstelling van de steekproef. Door het includeren van verschillende functieprofielen uit meerdere ziekenhuizen, met variatie in het aantal jaren werkervaring, konden uiteenlopende perspectieven op de rol van de hoofdverpleegkundige bij opgelegde verandering geïdentificeerd worden. Daarnaast werd de kans op bias verminderd door het toepassen van reflexiviteit en triangulatie.

4.2 Aanbevelingen

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

Toekomstig onderzoek kan verder inzicht bieden in leiderschap bij opgelegde veranderingen door na te gaan hoe de geïdentificeerde spanningsvelden zich voordoen bij andere vormen van opgelegde veranderingen binnen ziekenhuizen aangezien veranderprocessen in de gezondheidszorg sterk contextafhankelijk zijn.

Daarnaast is er nood aan verder onderzoek dat specifiek focust op de psychologische dimensie van leiderschap tijdens verandering. De resultaten wijzen op het belang van emotionele arbeid, rolambiguïteit en draagkracht bij hoofdverpleegkundigen wat aansluit bij literatuur die leiderschap in verandercontexten beschrijft als emotioneel belastend en onzeker (10, 15, 32). Vervolgonderzoek kan nagaan hoe deze factoren evolueren doorheen verschillende fasen van veranderprocessen en welke ondersteuningsmechanismen beschermend werken tegen uitputting en verlies van draagkracht.

Aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk

Voor de dagelijkse praktijk tonen de resultaten aan dat hoofdverpleegkundigen ondersteuning nodig hebben in het hanteren van paradoxen tijdens de opgelegde verandering. Effectief leiderschap bestaat niet uit het maken van eenduidige keuzes maar uit het voortdurend balanceren tussen tegenstrijdige maar onderling afhankelijke verwachtingen, wat aansluit bij paradoxaal leiderschap (20-22). Ziekenhuizen kunnen dit ondersteunen door ruimte te voorzien voor reflectie, intervisie en coaching waarin spanningsvelden bespreekbaar worden gemaakt. Dergelijke ondersteuningsvormen kunnen bijdragen aan het versterken van leiderschap en veranderingsbereidheid binnen teams (29). Daarnaast is het belangrijk om tijd en vertraging te erkennen als randvoorwaarde voor duurzame verandering. Verandering vraagt ruimte voor betekenisgeving, afstemming en bijsturing en een te hoog opgelegd tempo kan leiden tot weerstand, veranderingsmoeheid en beperkte verankering (26, 27). Door vertragen expliciet te benoemen en te hanteren als een bewuste leiderschapsstrategie kan worden bijgedragen aan meer gedragen en duurzame veranderprocessen.

Aanbevelingen voor beleid

De bevindingen suggereren dat opgelegde veranderingen niet uitsluitend mogen worden gestuurd vanuit efficiëntie- of capaciteitsargumenten maar dat er rekening moet worden gehouden met de implementatiecapaciteit van afdelingen en hoofdverpleegkundigen. Beleidsmakers en ziekenhuisdirecties worden aangemoedigd om verandering te benaderen als een complex adaptief proces waarbij interacties tussen context, actoren en timing bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat (4, 23).

Het ondersteunen van hoofdverpleegkundigen via realistische planningen, duidelijke rolverwachtingen en toegang tot begeleiding kan bijdragen aan het voorkomen van emotionele uitputting en het versterken van de draagkracht van zowel hoofdverpleegkundigen als teams (32, 33).

5. Conclusie

Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de rol van hoofdverpleegkundigen bij de opgelegde verandering, het samenvoegen van twee verblijfsafdelingen tot één afdeling en de strategieën die hierin faciliteren. De resultaten tonen aan dat leiderschap in deze context niet kan worden herleid tot een vast stappenplan maar vorm krijgt in het gelijktijdig hanteren van organisatorische, relationele en psychologische spanningsvelden. Deze spanningsvelden staan niet los van elkaar maar beïnvloeden en versterken elkaar binnen een complex veranderproces. Het succes van de opgelegde verandering is niet enkel afhankelijk van de inhoud of het ontwerp maar in sterke mate van de manier waarop deze op afdelingsniveau wordt vertaald, gedragen en gestuurd. Hoofdverpleegkundigen vervullen hierbij een sleutelrol als verbindingsfiguur tussen beleid en praktijk waarbij hun vermogen om spanningsvelden te hanteren bepaalt in welke mate verandering gedragen, geïntegreerd en duurzaam verankerd wordt. De bevindingen van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor onderzoek, praktijk en beleid door te verduidelijken hoe leiderschap bij opgelegde veranderingen vorm krijgt en welke condities bijdragen aan duurzame verandering in ziekenhuizen.

Een GenAI-tool werd gebruikt ter ondersteuning van taalcorrectie en herformulering. De inhoudelijke keuzes, analyse en interpretatie van dit onderzoek zijn volledig het resultaat van het eigen werk van de onderzoeker in opleiding.

6. Referenties

1. Algethami FM, Alghaylani AS, Alrabie SM, Aljrdahi AWA, Alhurani AA, Altowairqi MA, et al. Leading Change in Healthcare: A Systematic Review of Middle Management's Role. *Journal of Posthumanism*. 2026;6(2):135-50.
2. Cheraghi R, Ebrahimi H, Kheibar N, Sahebihagh MH. Reasons for resistance to change in nursing: an integrative review. *BMC Nurs*. 2023;22(1):310.
3. Silvola S, Restelli U, Croce D, Basu D. Change management for services redesign in healthcare: a conceptual framework. *J Prev Med Hyg*. 2024;65:E410-E33.
4. Braithwaite J, Westbrook J, Coiera E, Runciman WB, Day R, Hillman K, et al. A systems science perspective on the capacity for change in public hospitals. *Isr J Health Policy Res*. 2017;6:16.
5. Lavergne T, Janssens H. Tekort aan verpleegkundigen en crisis van het 'zorgen voor'. 2024.
6. Gerkens S, Lavergne T, Lefèvre M, Bouckaert N, Levy M, Maertens de Noordhout C, et al. Performance of the Belgian Health System: report 2024. Brussel: Belgian Healthcare Knowledge Centre (KCE). 2024.
7. Qtait M. Systematic Review of Head Nurse Leadership Style and Nurse Performance. *International Journal of Africa Nursing Sciences*. 2023;18.
8. Gonzalez-Garcia A, Pinto-Carral A, Villorejo JS, Marques-Sanchez P. Competency Model for the Middle Nurse Manager (MCGE-Logistic Level). *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(8).
9. Giessner SR, Dawson JF, Horton KE, West M. The impact of supportive leadership on employee outcomes during organizational mergers: An organizational-level field study. *J Appl Psychol*. 2023;108(4):686-97.
10. Oreg S, Berson Y. Leaders' Impact on Organizational Change: Bridging Theoretical and Methodological Chasms. *Academy of Management Annals*. 2019;13(1):272-307.
11. Abdelhafiz IM, Alloubani AM, Almatari M. Impact of leadership styles adopted by head nurses on job satisfaction: a comparative study between governmental and private hospitals in Jordan. *J Nurs Manag*. 2016;24(3):384-92.
12. Austin T, Chreim S, Grudniewicz A. Examining health care providers' and middle-level managers' readiness for change: a qualitative study. *BMC Health Serv Res*. 2020;20(1):47.
13. Beasley L, Grace S, Horstmanshof L. Assessing individual readiness for change in healthcare: a review of measurement scales. *J Health Organ Manag*. 2021;ahead-of-print(ahead-of-print).
14. Burke S, Sims D, Lazzara E, Salas E. Trust in leadership: A multi-level review and integration. *The Leadership Quarterly*, 18, 606-632. *The Leadership Quarterly*. 2007;18:606-32.
15. Wooten KC, LP W. Towards a theory of change role efficacy. *Human Relations*. 1989;42:651-9.
16. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*. 2007;19 (6):349 - 57.
17. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*. 2008;3(2):77-101.
18. Ahmed SK, Mohammed RA, Nashwan AJ, Ibrahim RH, Abdalla AQ, M. Ameen BM, et al. Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*. 2025;6.
19. Lincoln Y, Guba E. *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills (CA): Sage. 1985.
20. Smith W, Lewis M. Toward a theory of paradox: a dynamic equilibrium model of organizing. *Acad Manage Rev*. 2011;36(2):381-401.
21. Zhang Y, Waldman DA, Han Y-L, Li X-B. Paradoxical Leader Behaviors in People Management: Antecedents and Consequences. *Academy of Management Journal*. 2015;58(2):538-66.
22. Quinn R, Cameron K. *Paradox and transformation: toward a theory of change in organization and management*. Cambridge, MA: Baillinger; . 1988.
23. Borghi J, Ismail S, Hollway J, Kim RE, Sturmberg J, Brown G, et al. Viewing the global health system as a complex adaptive system - implications for research and practice. *F1000Res*. 2022;11:1147.
24. Van de Ven A, Poole M. Explaining development and change in organizations. *Acad Manage Rev*. 1995;20(3):510-40.
25. Vis C, van Bodegom-Vos L, Hipple-Walters B, Powell BJ, Ista E, van Nassau F. Applied methods for matching implementation strategies to determinants: a scoping review of scientific and grey literature, and qualitative exploration of practice experiences. *Implement Sci*. 2025;21(1):14.

26. Waterworth S. Time and change in health care. *Leadersh Health Serv (Bradf Engl)*. 2017;30(4):354-63.
27. Bluedorn A, Jaussi K. Leaders, followers, and time. *Leadership Quarterly*. 2008;19(6):654-68.
28. Thurlow A, Helms Mills J. Change, talk and sensemaking. *Organ Change Manag*. 2009;22(5):459-79.
29. Wanser L, H L. The role of leadership in change in healthcare facilities: a qualitative study. *Am J Manag*. 2021;21(1):16-31.
30. Lu H, Li F. The Dual Effect of Transformational Leadership on Individual- and Team-Level Performance: The Mediatlional Roles of Motivational Processes. *Front Psychol*. 2021;12:606066.
31. Humphrey R. How do leaders use emotional labor? *J Organ Behav*. 2012;33(5):740-4.
32. Morrison VJ, Jensen AL. Between a rock and a hard place: Nurse managers' experiences of large-scale organizational change in the public health service. *J Adv Nurs*. 2022;78(10):3385-97.
33. Groulx P, Maisonneuve F, Harvey JF, Johnson KJ. The ripple effect of strain in times of change: how manager emotional exhaustion affects team psychological safety and readiness to change. *Front Psychol*. 2024;15:1298104.

7. Bijlagen

7.1 Bijlage 1: Interviewgids

Interviewguide



Als inleiding wordt de focus, het onderwerp van het gesprek geschetst:

Bedankt dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek. In het kader van mijn master proces- en systeeminnovatie in de gezondheidszorg voer ik een kwalitatief onderzoek naar de rol van de leidinggevende, de strategieën die de leidinggevende hanteert en de strategieën die faciliteren bij de opgelegde verandering, het samenvoegen van twee verblijfsafdelingen tot één verblijfsafdeling, in ziekenhuizen.

In dit onderzoek ga ik op zoek naar uw ervaring m.b.t. de rol van de leidinggevende en de strategieën die gehanteerd werden door de leidinggevende.

Ik heb een aantal vragen voorbereid, maar u mag voornamelijk gewoon uw verhaal vertellen, u bent de ervaringsexpert. Er zijn geen juiste of foute antwoorden.

Het interview duurt 45 tot 75 minuten. U kunt op elk moment aangeven dat u wilt pauzeren, een vraag overslaan of stoppen met het interview.

Is alles wat ik u uitgelegd heb voldoende duidelijk? Is het goed voor u dat we het interview nu starten?

Na de inleiding stelt de interviewer zijn/haar openingsvraag:

Hoeervaarde u de rol van de leidinggevende / uw rol in de verandering?

- Hoe is het proces van de verandering verlopen?
- Hoe bent u met de verandering omgegaan?
- Wat vond je lastig/niet-helpend in deze verandering? Wat waren obstakels? Hoe ben je daarmee omgegaan?
- Wat vond je wel helpend? Hoe heb je daarop ingespeeld?

Er worden vragen gesteld om het verhaal van de participant te verdiepen:

1. Hoe heeft u dat ervaren?
2. Was dit helpend of minder helpend gedrag?
3. Kan u hier iets meer over vertellen?
4. Wat betekende dat voor u?
5. Hoe zou dat een rol gespeeld hebben?
6. Kunt u daar een voorbeeld van geven?

Er worden verbredende onderwerp-specifieke vragen gesteld als de participant niet meer spontaan andere elementen inbrengt:

- Welke stappen heeft u/ werden er genomen om deze verandering te implementeren?
- Welke aanpak werd er gehanteerd om het team door deze verandering te leiden?
- Wat vond u van de communicatie over de opgelegde verandering? En tijdens het proces?
- Was de reden(en) voor deze verandering duidelijk voor u en uw team?
- Welke vormen van weerstand ervaarde u en hoe werd er omgegaan met weerstand?
- Welke strategieën vond u het meest effectief om de weerstand te veranderen?
- Welke ondersteuning heeft al dan niet geholpen om met de verandering om te gaan?
- Hoe heeft deze verandering uw afdeling beïnvloed?
- Hoe heeft het uw eigen rol veranderd?
- Wat was er nodig om deze verandering tot een goed einde te brengen?
- Wat heeft u geleerd uit deze ervaring dat u zou toepassen bij een volgende verandering?
- Hoe ervaarde u zelf de opgelegde verandering?

Afsluitende vragen

- Welke vaardigheden wil u verder ontwikkelen om beter om te gaan met opgelegde veranderingen?
- Hoe denkt u dat ziekenhuizen beter kunnen omgaan met opgelegde veranderingen?
- Welke aanbevelingen zou u doen aan andere leidinggevenden die met een vergelijkbare situatie te maken krijgen?

7.2 Bijlage 2: Paradoxen, thema's en subthema's

Paradox 1: Structuur bieden versus flexibiliteit behouden

- Thema 3: Transparante en betekenisvolle communicatie
- Effectieve en gestroomlijnde communicatie
- Thema 4: Vooraf duidelijkheid creëren over richting en aanpak
- Beleid en kader uitzetten
 - Visie en doel bepalen
 - Plan van aanpak
- Thema 7: Analytisch en probleemgericht werken
- Analytische benadering
 - Probleemanalyse en inzicht
 - Prioriteiten stellen en bewaken
 - Werkbare structuur creëren

Paradox 2: Individuele besluitvorming versus collectieve betrokkenheid

- Thema 2: Constructieve sturing
- Ruimte geven om te groeien
 - Erkennen en versterken wat goed gaat
- Thema 3: Transparante en betekenisvolle communicatie
- Verwachtingen helder stellen
- Thema 8: Verantwoordelijkheid opnemen onder druk
- Beslissingen nemen
 - Begrenzen
- Thema 9: Empowerment
- Inspraak
 - Eigenaarschap en betrokkenheid

Paradox 3: Individuele begeleiding versus teamgerichte ondersteuning

- Thema 6: Samenwerken en verbondenheid vormgeven
- Samenwerking bevorderen
 - Teamdynamiek en samenhang versterken
- Thema 14: Individuele begeleiding en ontwikkeling ondersteunen

Paradox 4: Nabijheid versus autonomie stimuleren

Thema 1: Relationale beschikbaarheid van de leidinggevende

- Toegankelijkheid en nabijheid
- Oprechte aandacht en luisteren
- Empathie en emotionele erkenning
- Veiligheid en integriteit

Thema 6: Samenwerken en verbondenheid vormgeven

- Instappen in de verandering

Thema 9: Empowerment

- Autonomie en creativiteit
- Eigenaarschap en betrokkenheid

Paradox 5: Zorg dragen voor anderen versus zorg dragen voor zichzelf

Thema 1: Relationale beschikbaarheid van de leidinggevende

- Empathie en emotionele erkenning

Thema 5: Persoonlijke draagkracht en reflexief handelen

- Zelfbewustzijn
- Blijven geloven in jezelf als leidinggevende
- Ondersteund worden als leidinggevende

Thema 11: Veerkracht van team en leidinggevende

- Teamveerkracht
- Veerkracht van de leidinggevende

Paradox 6: Tempo maken versus vertragen

Thema 12: Tijd als instrument voor een duurzame verandering

- Tempo bewust reguleren
- Stap voor stap veranderen en verankeren
- Tijd geven voor betrokkenheid en groei
- Tijd als conditie aangeven

Paradox 7: Vertrouwen uitstralen versus ervaren van onzekerheid

Thema 3: Transparante en betekenisvolle communicatie

- Betekenis geven aan het waarom
- Open en continue dialoog

Thema 5: Persoonlijke draagkracht en reflectief handelen

- Blijven geloven in de verandering
- Doorzetten
- Leren en reflecteren

Thema 13: Vertrouwen doelbewust opbouwen en onderhouden

- Vertrouwen stapsgewijs opbouwen
- Vertrouwen om te kunnen loslaten
- Vertrouwen opbouwen via professionele en inhoudelijke consistentie

Thema 10: creëren van een gedeelde identiteit en werking, werd niet benaderd als een afzonderlijk spanningsveld, maar als het inhoudelijke veranderproces waarbij twee verblijfsafdelingen worden samengevoegd tot één verblijfsafdeling. Dit thema omvat het toewerken naar een gedeelde basis, gezamenlijke werkwijzen en een gevoel van samenhang tussen afdelingen. De beschreven paradoxen laten zien hoe hoofdverpleegkundigen dit veranderproces begeleiden door voortdurend te balanceren tussen verschillende, soms tegenstrijdige, verwachtingen in de dagelijkse praktijk.

7.3 Bijlage 3: Schema thema's en subthema's per profiel en per ziekenhuis

Deze bijlage geeft een overzicht van de ontwikkelde subthema's en thema's binnen de reflexieve thematische analyse, weergegeven per profiel en per casus (ziekenhuis). De weergegeven verhoudingen illustreren bij hoeveel participanten binnen een bepaald profiel of binnen een specifieke casus (ziekenhuis) een thema of subthema werd geïdentificeerd.

Thema's en subthema's per profiel

	Manager	Stafmede- werker	Hoofd- verpleeg- kundige	Adjunct- hoofdverpleeg- kundige	Verpleeg- kundige
Thema 1: Relationale beschikbaarheid	3/3	2/2	4/4	1/1	3/3
Toegankelijkheid en nabijheid	2/3	1/2	3/4	1/1	3/3
Oprechte aandacht en luisteren	2/3	2/2	4/4	1/1	3/3
Empathie en emotionele erkenning	2/3	1/2	2/4		1/3
Veiligheid en integriteit	3/3		3/4		1/3
Thema 2: Constructieve sturing	3/3	2/2	4/4	1/1	1/3
Richting geven	3/3	2/2	3/4	1/1	1/3
Erkennen en versterken wat goed gaat	1/3	1/2	2/4	1/1	
Ruimte geven om te groeien			2/4	1/1	
Thema 3: Transparante en betekenisvolle communicatie	3/3	2/2	4/4	1/1	3/3
Betekenis geven aan het waarom of het waarom expliciteren en betekenis geven	3/3	2/2	4/4	1/1	2/3
Verwachtingen helder stellen	2/3		4/4		2/3
Effectieve en gestroomlijnde communicatie	2/3	1/2	3/4		3/3
Open en continue dialoog	2/3	2/2	4/4	1/1	1/3
Thema 4: Vooraf duidelijkheid creëren over richting en aanpak	2/3	2/2	4/4	1/1	3/3
Beleid en kader uitzetten	2/3	2/2	1/4		2/3
Visie en doel bepalen	1/3	2/2	1/4	1/1	3/3
Plan van aanpak	2/3	1/2	3/4	1/1	3/3
Thema 5: Persoonlijke draagkracht en reflectief handelen	3/3	2/2	4/4	1/1	1/3
Zelfbewustzijn			1/4		1/3
Blijven geloven in de verandering	2/3		2/4	1/1	
Blijven geloven in jezelf			1/4		
Leren en reflecteren	1/3	1/2	3/4	1/1	1/3
Ondersteund worden als leidinggevende	1/3	2/2	3/4	1/1	
Doorzetten	1/3	2/2	3/4		
Thema 6: Samenwerken en verbondenheid vorm geven	2/3	1/2	4/4	1/1	2/3
Instappen in de verandering	2/3		3/4		
Samenwerking bevorderen	1/3	1/2	3/4		
Teamdynamiek en samenhang versterken			2/4		
Informeel verbinding en teamvorming faciliteren	2/3		2/4	1/1	2/3

	Manager	Stafmede- werker	Hoofd- verpleeg- kundige	Adjunct- hoofdverpleeg- kundige	Verpleeg- kundige
Thema 7: Analytisch en probleemgericht werken	2/3		4/4		2/3
Analytische benadering			2/4		
Probleemanalyse en inzicht	1/3		2/4		2/3
Prioriteiten stellen en bewaken			3/4		
Werkbare structuur creëren	1/3		4/4		2/3
Thema 8: Verantwoordelijkheid opnemen onder druk	2/3	1/2	4/4	1/1	1/3
Beslissingen nemen	2/3	1/2	4/4	1/1	1/3
Begrenzen		1/2	3/4		1/3
Thema 9: Empowerment	3/3	1/2	4/4	1/1	3/3
Autonomie en creativiteit		1/2	4/4	1/1	1/3
Eigenaarschap en betrokkenheid	3/3	1/2	3/4		2/3
Inspraak	3/3	1/2	4/4	1/1	3/3
Motiveren en inspireren	1/3	1/2	2/4	1/1	
Thema 10: integratie van afdelingen via een gedeelde basis	2/3	1/2	4/4	1/1	2/3
Gemeenschappelijke basis vormen	2/3		3/4	1/1	1/3
Gemeenschappelijke werking	2/3	1/2	4/4	1/1	1/3
Gelijkwaardigheid bewaken	1/3		1/4		
Stabiliteit			2/4		
Thema 11: Veerkracht van team en leidinggevende		2/2 (voor leiding- gevende)	4/4 (voor team)		
Teamveerkracht			4/4		
Veerkracht van de leidinggevende		2/2			
Thema 12: Tijd als instrument voor een duurzame verandering	2/3	2/2	4/4	1/1	3/3
Tempo bewust reguleren	1/3	1/2	2/4		3/3
Stap voor stap veranderen en verankeren	1/3	1/2	2/4	1/1	1/3
Tijd geven voor betrokkenheid en groei		1/2	4/4	1/1	3/3
Tijd als conditie aangeven	1/3	1/2	3/4		
Thema 13: Vertrouwen doelbewust opbouwen en onderhouden	2/3	1/2	3/4		1/3
Vertrouwen stapsgewijs opbouwen	1/3		1/4		1/3
Vertrouwen om te kunnen loslaten			3/4		1/3
Vertrouwen opbouwen via professionele en inhoudelijke consistentie	1/3	1/2	1/4		
Thema 14: Individuele begeleiding en ontwikkeling ondersteunen	3/3	1/2	3/4	1/1	2/3

Thema's en subthema's per casus (per ziekenhuis)

	Casus 1	Casus 2	Casus 3
Thema 1: Relationale beschikbaarheid	5/5	3/3	5/5
Toegankelijkheid en nabijheid	3/5	2/3	4/5
Oprechte aandacht en luisteren	5/5	1/3	4/5
Empathie en emotionele erkenning	1/5	1/3	4/5
Veiligheid en integriteit	3/5	1/3	3/5
Thema 2: Constructieve sturing	5/5	2/3	5/5
Richting geven	3/5	2/3	3/5
Erkennen en versterken wat goed gaat	2/5		2/5
Ruimte geven om te groeien	2/5		2/5
Thema 3: Transparante en betekenisvolle communicatie	5/5	3/3	5/5
Betekenis geven aan het waarom of het waarom expliciteren en betekenis geven	5/5	2/3	5/5
Verwachtingen helder stellen	2/5	2/3	4/5
Effectieve en gestroomlijnde communicatie	4/5	3/3	2/5
Open en continue dialoog	5/5	2/3	4/5
Thema 4: Vooraf duidelijkheid creëren over richting en aanpak	5/5	3/3	4/5
Beleid en kader uitzetten	3/5	1/3	4/5
Visie en doel bepalen	5/5		1/5
Plan van aanpak	5/5	3/3	2/5
Thema 5: Persoonlijke draagkracht en reflectief handelen	5/5	2/3	5/5
Zelfbewustzijn	1/5		1/5
Blijven geloven in de verandering	3/5		3/5
Blijven geloven in jezelf	1/5		
Leren en reflecteren	5/5		1/5
Ondersteund worden als leidinggevende	4/5		4/5
Doorzetten	2/5	2/3	1/5
Thema 6: Samenwerken en verbondenheid vorm geven	4/5	2/3	4/5
Instappen in de verandering	1/5	1/3	2/5
Samenwerking bevorderen	2/5	1/3	1/5
Teamdynamiek en samenhang versterken	1/5	1/3	1/5
Informele verbinding en teamvorming faciliteren	3/5		3/5
Thema 7: Analytisch en probleemgericht werken	3/5	1/3	4/5
Analytische benadering	1/5		1/5
Probleemanalyse en inzicht	2/5		3/5
Prioriteiten stellen en bewaken	1/5		2/5
Werkbare structuur creëren	3/5	1/3	3/5

	Casus 1	Casus 2	Casus 3
Thema 8: Verantwoordelijkheid opnemen onder druk	5/5	1/3	3/5
Beslissingen nemen	5/5	1/3	3/5
Begrenzen	3/5		2/5
Thema 9: Empowerment	5/5	3/3	4/5
Autonomie en creativiteit	4/5	1/3	2/5
Eigenaarschap en betrokkenheid	4/5	2/3	3/5
Inspraak	5/5	3/3	4/5
Motiveren en inspireren	2/5	1/3	1/5
Thema 10: integratie van afdelingen via een gedeelde basis	3/5	1/3	3/5
Gemeenschappelijke basis vormen	3/5	1/3	3/5
Gemeenschappelijke werking	3/5	3/3	3/5
Gelijkwaardigheid bewaken			2/5
Stabiliteit	1/5		1/5
Thema 11: Veerkracht van team en leidinggevende	2/5	1/3	3/5
Teamveerkracht	1/5	1/3	2/5
Veerkracht van de leidinggevende	1/5		1/5
Thema 12: Tijd als instrument voor een duurzame verandering	5/5	2/3	5/5
Tempo bewust reguleren	4/5	1/3	2/5
Stap voor stap veranderen en verankeren	5/5		1/5
Tijd geven voor betrokkenheid en groei	4/5	2/3	3/5
Tijd als conditie aangeven	1/5		4/5
Thema 13: Vertrouwen doelbewust opbouwen en onderhouden	4/5	1/3	3/5
Vertrouwen stapsgewijs opbouwen	1/5	1/3	1/5
Vertrouwen om te kunnen loslaten	2/5		2/5
Vertrouwen opbouwen via professionele en inhoudelijke consistentie	3/5		
Thema 14: Individuele begeleiding en ontwikkeling ondersteunen	5/5	2/3	3/5